

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061109-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: IVALDO MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

PROCESSO CIVIL E SAÚDE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA PARA CORREÇÃO DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA, COM ESFÍNCTER ARTIFICIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA - QUADRO FÁTICO INALTERADO - DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA POR AUSENCIA DE PERICULUM IN MORA - ART 300 DO CPC - PALIATIVO FORNECIDO POR MEIO DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR, QUE DISPONIBILIZA GRATUITAMENTE FRALDAS GERIÁTRICAS PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA -ALTERNATIVA PARA DIMINUIÇÃO DOS EFEITOS NEGATIVOS DA INCONTINÊNCIA, ENQUANTO AGUARDA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA - AGRAVO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de setembro de 2024.

5061109-18.2024.4.02.5101

510014248443 .V4

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5061109-18.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: IVALDO MOREIRA DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

A presente **MEDIDA DE URGÊNCIA** foi interposta pela parte autora, buscando a reforma da decisão proferida pelo Juizado Especial Federal de origem que indeferiu pedido de antecipação de tutela para determinar a realização de **cirurgia para correção de incontinência urinária masculina, com esfíncter artificial**.

O autor foi submetido a cirurgia de prostatectomia radical devido a neoplasia de próstata em **03/02/2021**, conforme fl.12 do evento 1, ANEXO2 dos autos originários. Em informações do Hospital Federal do Andaraí, foi dito que o autor encontra-se **aguardando cirurgia** para correção de incontinência urinária com esfíncter. Apresentou **documento médico não datado** (fl. 13 do evento 1, ANEXO2), **de quando possuía 65 anos (atualmente está com 66) solicitando risco cirúrgico** para esfíncter artificial.

Em informações do Hospital Federal do Andaraí (fl. 17 do evento 1, ANEXO2), **datada de 06/05/2024, foi informado que o autor encontra-se aguardando cirurgia** para correção de incontinência urinária com esfíncter artificial, **sendo o primeiro da fila para este procedimento**. O referido nosocômio ainda informou que, **apesar de ter solicitado os esfíncteres artificiais necessários, ainda não os recebeu do Ministério da Saúde** e que convive com outras dificuldades de abastecimento e paralisações.

A decisão de 1a instancia foi mantida por atender aos parâmetros legais.

Apresentadas contrarrazões, vieram conclusos.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Analizando o processo em 1a instancia, verifica-se que o quadro se mantem inalterado desde o exame do pedido por este órgão jurisdicional.

Pelas informações prestadas pelo Hospital Federal do Andaraí e pela Câmara de Resolução de Litígios em Saúde, verifica-se que o procedimento cirúrgico requerido é fornecido pelo SUS. Entretanto, apesar de o autor ser o **primeiro da fila para sua realização, ainda não obteve o procedimento por ausência de material necessário** no referido nosocômio:

DESPACHO

HFA/CASS/HFA/DGH/SAES/MS

Rio de Janeiro, 06 de maio de 2024.

O referido paciente encontra-se aguardando cirurgia para correção de incontinência urinária masculina, com esfíncter artificial. É o primeiro da fila para ESTE TIPO DE PROCEDIMENTO (lembrando que temos pacientes inseridos na fila para os mais diversos tipos de cirurgias).

Não podemos, infelizmente, informar previsão de sua internação e cirurgia pois, embora solicitados reiteradamente, não recebemos os esfíncteres artificiais necessários para o seu caso. Além do que, convivemos com outras dificuldades de abastecimento e paralisações.

Atenciosamente,

Pedro Augusto V. R. Souza
Mat:1191144
Chefe do Serviço de Urologia

O unico obice, portanto, para a realização do procedimento é o fornecimento pelo Ministerio da Saude, órgão federal representado pela União, do material essencial ao procedimento, sem o qual não há como realizar a cirurgia.

Dado que o pedido para realização do risco cirúrgico foi efetuado quando ele ainda tinha 65 anos, considerando sua data de aniversário, pode-se concluir que está a espera da referida cirurgia **há pelo menos 3 meses**, sem desconsiderar que a questão provavelmente surgiu a partir da cirurgia de retirada da próstata realizada em 2021. Entretanto, apesar de todos os evidentes e elevados dissabores ocasionados pela incontinência urinária, não há como caracterizar urgência por ausência de risco de morte do autor. Mais do que isso: a cirurgia não é realizada, não por existencia de ourtos pacientes em fila, mas simplesmente porque o Ministerio da saude não fornece o que caberia a ele fornecer.

O problema é ratificado pelo Hospital do Andaraí que, inclusive, atesta que o autor tem problemas de saude mais graves do que o procedimento que pretende judicialmente:

Paciente com histórico de prostatectomia radical por adenocarcinoma da próstata, realizada em 2021. Evoluiu com quadro de incontinência urinária, necessitando usar absorventes. Encaminhado para fisioterapia pélvica no intuito de adquirir gradual continência urinária. Diante da persistência de incontinência, foi indicada a realização de implante de sling masculino ou de esfíncter artificial de 2023, sendo solicitados os exames pré-operatórios na ocasião e inserido em fila cirúrgica para este tipo de procedimento em setembro de 2023.

Em abril de de 2024, durante avaliação no ambulatório de Uro-Oncologia, foi identificada recidiva bioquímica do adenocarcinoma da próstata, através do PSA (0,289), sendo encaminhado para avaliação na Oncologia Clínica. Ainda não possuímos resposta desta avaliação.

Não temos disponíveis os Slings Masculinos, apesar de reiteradamente solicitados. Quanto aos esfíncteres artificiais, recebemos de tempos em tempos, 02 unidades a cada vez e chamamos sempre os pacientes da fila. Neste momento possuímos 01 unidade e o paciente se encontra na sétima posição da fila específica para este tipo de procedimento e na 103 posição geral.

Quanto ao risco para sua saúde, podemos afirmar que a recidiva bioquímica de tumor de próstata é a questão mais significativa em termos de potencial gravidade e que a incontinência urinária, embora não apresente riscos mais

significativos à saúde em geral, implica em significativa queda na qualidade de vida.

Neste ponto, a adesão ao programa de fraldas geriátricas pelo Programa Farmácia Popular do Brasil parece ser a solução paliativa como posto na liminar ante a inércia do Executivo.

Nesses termos, diante da ausência de urgência, em que pese o flagrante e revoltante descaso do Ministério da Saúde, existe alternativa paliativa para diminuição dos efeitos negativos da incontinência que são, neste primeiro momento, o que resta ao autor ante, repita-se, o descaso e indiferença do Poder Executivo.

Ante o exposto, **voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.** Sem custas ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios (art 85, § 11o do CPC). **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa. É como voto.

5061109-18.2024.4.02.5101

510014248442 .V3